<table>
<tr><td>기관명</td><td>1. 메이지가쿠인대학
일본 복지정책</td><td>방문일자</td><td>2026.9.14.(월)~18.(금)</td></tr>
<tr><td>운영주체</td><td>-</td><td>홈페이지</td><td>https://www.meijigakuin.ac.jp/</td></tr>
<tr><td>기관장명</td><td>메이지가쿠인대학 총장
무라타 레온 (村田玲音)</td><td>담당자명</td><td>김선모</td></tr>
<tr><td>주소/연락처</td><td colspan="3">2-37 Shirokanedai, Minato City, Tokyo 108-8636/ +81354215111</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">
○ 일본 인구 및 취약계층 현황
<table>
<tr><th>구분 (단위:명)</th><th>전체</th><th>생활보호수급자</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>총 인구</td><td>1억 2,297만</td><td>165만</td><td>인구감소 중</td></tr>
<tr><td>노인</td><td>3,619만(29%)</td><td>90만</td><td>초고령화사회</td></tr>
<tr><td>장애인</td><td>1,164만(9%)</td><td>41만</td><td>-</td></tr>
</table>
출처 : 2026년 총무성 인구추계기준&후생노동성 참고
○ 일본 복지 발전사
1. 제2차 세계대전 이전 : 자본주의 산업화와 군국주의적 동원 위해 1922년 건강보험법등이 제정. 권리보다 시혜적 성격이 강함
2. 제2차 세계대전 이후 : 복지가 헌법을 통해 보편적 기본권으로 격상, 1961년 '국민연금・건강보험'으로 일본 특유의 다층적 사회보장 체계 완성
3. 2000년대 이후 : 초고령화 사회 진입 대응, 2000년 개호보험 도입, 대형시설 중심에서 지역사회 안에서 의료・요양・주거를 통합제공하는 '지역포괄케어시스템'으로 전환

○ 일본 대표 복지정책
1. 개호보험
- 가족 돌봄 한계 극복 위해 신설된 제5의 사회보험. 40세부터 보험료 의무 납부, (제1호) 65세 이상 이상 또는 노인성 질환을 겪는 (제2호) 40세~64세가 요개호로 인정 받아 거동 불편 등으로 간병(개호)이 필요할 때 요양보호사의 방문 요양이나 요양시설 이용 비용을 지원 받음 *사회보험(의료/연금/개호/고용/산재)
2, 지역포괄케어시스템
- 고령자가 중증 요양 상태가 될 시 시설에 격리되지 않고, 자신이 살아온 지역사회에서 삶을 영위할 수 있도록 돕는 포괄적 돌봄 체계. 기존의 '병원·시설 중심'에서 '지역·재택 중심'으로 복지의 패러다임을 완전히 전환한 일본 정부(후생노동성)의 핵심 정책이자 커뮤니티 케어의 세계적인 성공 모델
- 5대 시스템 핵심 요소 : 고령자의 일상을 유지하기 위해 대략 도보 30분 이내의 생활권역 안에서 다음 5가지 요소가 톱니바퀴처럼 통합적으로 제공되도록 설계
<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>주거</td><td>시스템의 가장 밑바탕이 되는 근간. 신체 기능과 경제력에 맞춘 안전한 주거 환경 및 무장애 주택, 안부 확인이 결합 된 임대주택 보장</td></tr>
<tr><td>의료</td><td>의원(가정의)부터 자택으로 찾아가는 방문 진료, 응급 시 입원할 수 있는 급성기 병원까지 연계</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

개호/요양	요양보호사의 방문 요양, 낮 시간 동안 시설에 머무는 통소(데이서비스), 단기 숙박 등을 이용자의 상태 변화에 맞춰 유연하게 제공
예방	요양 상태로 악화되는 것을 막기 위해 지역 내 체조 교실, 영양 관리, 사회 참여 활동 등을 지원
생활지원	자원봉사자, NPO(비영리단체), 지역 주민 등이 협력하여 식사 배달(배식), 쓰레기 배출, 쇼핑 보조 등 일상생활 지원

3. 돌봄의 과학화(2024)

- 2024년 일본 후생노동성이 이례적으로 의료, 개호(요양), 장애복지 보수를 동시에 개정. 심각한 돌봄 인력 유출을 막고 경영을 안정화하기 위한 고육지책.
- 아웃컴(Outcome) 중심 평가 도입: 과거에는 돌봄 서비스를 단순히 '몇 번 제공했는가'에 초점을 맞췄다면, 이제는 국가 데이터베이스(LIFE 시스템)를 활용하여 환자의 일상생활수행능력(ADL)이나 배설 능력이 실질적으로 개선·유지되었음을 과학적으로 입증하면 기관에 높은 인센티브를 지급.

4. 민관융합의 완성: 2025년 개정 주택 세이프티넷법

- 2025년 전면 시행된 국토교통성 관할의 법안. 단신 고령자나 취약계층의 고독사 및 임대료 체납 리스크 때문에 민간 집주인들이 임대를 거부하는 현상을 원천적으로 막기 위해 제정
- '거주 서포트 주택' 신설: 집주인과 '거주지원법인'이 연계하여 입주자에게 인체감지 센서 등 ICT 안부 확인, 주기적 방문, 복지 서비스 연계를 입주 기간 내내 제공하는 새로운 임대주택 모델

5. 봉사활동: 수혜자에서 주체적 공헌자로의 전환 패러다임

- 자원봉사가 최근 복지 수혜자를 '돌봄 받는 객체'에서 '지역사회 기여하는 능동적 주체'로 변모. 인구 감소로 인한 일손 부족과 노인 고립 문제 해결하는 혁신 모델로 평가
- 노동법 규제 완화: 2024년, 후생노동성은 치매 환자가 사회참여 활동 통해 받는 '사례금(謝礼)'이 근로의 대가가 아닌 사회참여 목적일 경우, 노동기준법상 최저임금 규정에 종속되지 않고 수령 가능하다는 가이드라인(유권해석)을 발표
- (도쿄도 마치다시 'DAYS BLG!'): 치매 환자가 시설 격리가 아닌 지역 자동차 매장에서 세차를 하거나 보육원에서 종이접기, 구현동화 활동을 정규 프로그램으로 편성. 환자 스스로 '자신의 쓸모'를 확인하여 자존감을 회복하고 인지 기능 저하를 지연시키는 강력한 치료 모델로 작용

○ 복지 이슈

- 돌봄 인력 절벽: 일본 베이비붐 세대가 75세 이상 고령자에 진입하는 2025년을 기점으로 중증 개호 수요가 폭발, 돌봄 인력이 부족하여 '개호 난민' 발생이 현실화

▶ 요양시설 도산 중(인력난 및 물가상승)

- 영 케어러(Young Carer) 문제: 미성년자&청년이 만성 질환을 앓는 조부모나 부모를 홀로 돌보며 사회적으로 고립되는 현상.

▶ 2024년 개정된 아동복지법으로 국가적 지원 근거가 마련.

- 노노개호(老老介護) 한계와 '고독사' 급증 : 80대 노인이 90대 부모를 돌보거나, 70대 노인 부부가 서로 돌보는 '노노개호'가 일상화. 체력·정신적 한계에 동반 자살(개호 살인)을 하거나, 홀로 사망하는 고독사가 심각한 사회 문제.
- 장애인 '고용 대행 비즈니스' 논란 : 기업이 고용률을 맞추기 위해 직접 채용 대신, 농장 등을 대여해 주는 '장애인 고용 대행 비즈니스(기업 명의만 빌려주고 실질적 업무는 없는 형태)'를 편법으로 이용
- 장애인의 고령화와 '부모 사후' 문제 : '가족 돌봄'에 의존했던 중증 장애인이 부모가 사망하거나 요양병원에 입원하는 '부모 사후' 문제 발생. 남겨진 중증 장애 고령자를 장애인 그룹홈에서 수용해야 하지만, 돌볼 인력과 인프라가 부족.

○ **워크숍 지역 및 기관 특징**

지역	특징
도쿄도	고령화율(23.5%)은 전국 평균보다 낮으나, 65세 이상 노인 인구가 311만 명을 돌파하여 절대적인 취약계층 규모가 매우 큼. 특히 중증 개호 수요가 급증하는 75세 이상 인구가 181만 명에 달함. 큰 재정력을 바탕으로 독자적인 아동수당 지급, 저렴한 (Affordable) 주택 직접 공급, 지역밀착형 통소개호 인프라 구축 등에 선도적으로 나섬
오사카시	생산가능인구가 급감하는 가운데 고령화율이 24.6%에 달하며 복지 부담이 가중되고 있음. 빈곤층 밀집 등 복합적 취약계층 비중이 커, 저소득층의 임대료 차액을 공적으로 보조해 주는 고강도의 주거-복지 결합망 시뮬레이션을 논의하는 등 물리적 주거 안정 확보에 중점을 둠

기관	특징
메이지가쿠인대학	**대학 모토: DO for Others (다른 이를 위해 행동하라)* 1863년 설립, 일본 기독교 사회사업의 발상지라는 정통성을 지님. 체계화된 '자원봉사 제도'를 통해 학생이 단순 파견을 넘어, 개인 특기를 살린 맞춤형 공헌 활동을 주도적으로 발굴하도록 훈련. 정부가 추구하는 수혜자의 주체적 참여 기조와 완벽하게 맞닿아 있음
메지로대학	**대학모토: 育てて送り出す (키워서 세상으로 내보낸다)* 1923년 설립, 고독사, 정신질환 등 현대 복지 위기에 즉각 투입 가능한 실무형 인재 양성에 주력. 일본 복지의 3대 핵심 자격증인 「사회복지사」, 「정신보건복지사」, 「개호복지사」의 동시 취득을 훈련하여 공공 행정과 민간 헬스케어를 아우르는 실무자 배출

질문

메지로대학(김재근 교수)_장애인

1. 한·일 양국의 주거지원 모델 비교 시, 장애인의 물리적 주거권 보장과 돌봄 연계를 위해 한국이 참고할 일본 공간복지의 강점과 보완점은 무엇입니까?

	2. 배리어프리를 넘어 발달·정신장애인의 심리 안정을 돕는 '감각적 공간복지(유니버설 스페이스)'의 제도화 현황과 대표적 실천 사례는 무엇입니까? 3. 장애인 의무고용률 상향에 따른 편법(대행 비즈니스)을 방지하고 기업 내 실질적인 양질의 일자리를 창출하기 위해 일본 당국과 기관은 어떤 대안을 논의 중입니까? ○ **메이지가쿠인대학(김원경 교수)** 1. 한국의 재정 투입형 노인일자리가 일본처럼 지역사회 상부상조와 주체적 참여를 이끄는 '커뮤니티 기여 모델'로 진화하기 위한 노력은 무엇입니까? 2. 노노개호의 한계로 발생하는 동반 위기와 고독사 등 사각지대 고립 가구를 구제하기 위해 일본의 돌봄 및 주거·공간복지 정책은 어떻게 대응하고 있습니까? 3. 기존 신체 수발 중심에서 벗어나 노인의 건강수명 연장과 사회적 고립 방지를 견인하는 '예방 및 사회참여 중심' 정책의 구체적 틀은 무엇입니까? ○ **종합질문** 1. 의료와 개호를 통합 연계해 온 일본 지역포괄케어시스템이 현장과 어르신의 실제 삶에 가져온 가장 큰 성과와 강점은 무엇입니까? 2. 일본의 LIFE 시스템처럼 과정 중심인 한국의 복지 평가를 '데이터 기반 아웃컴(Outcome) 성과 평가'로 전환하기 위해 선행되어야 할 조건은 무엇입니까?
메모	